

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____

«___» _____ 20__ г.

Стандартная операционная процедура: «**Анафилактический шок**»

Общие положения

Параметр	Содержание
Название	Анафилактический шок (АШ)
Показания	Острое начало + нарушение дыхания/кровообращения + кожные проявления после контакта с аллергеном
Противопоказания	Нет (угрожающее жизни состояние)
Кто выполняет	Врач, фельдшер
Оснащение	Укладка для АШ, кислород, мешок Амбу, инфузионные системы
Документация	Карта вызова

Алгоритм по шагам

Шаг	Действие	Содержание	Примечание
1	Прекратить контакт	Остановить введение аллергена	Жгут выше инъекции на 25 мин (ослаблять каждые 10 мин)
2	Позиция	Без удушья — лежа с приподнятыми ногами; при удушье — сидя; беременные — на левом боку	
3	Адреналин	0,1% — 0,3–0,5 мл в/м в бедро	Повтор через 5 мин при неэффективности
4	Кислород	6–8 л/мин через маску с резервуаром	
5	Венозный доступ	Катетеризация периферических вен	
6	Инфузия	NaCl 0,9% 500–1000 мл в/в струйно	

7	Вторая линия	Преднизолон 60–120 мг в/в; антигистаминные	После стабилизации АД
8	Неэффективность 2+ доз адреналина в/м	Переход на в/в инфузию: 1 мл 0,1% на 100 мл NaCl	Под кардиомониторингом
9	Бронхоспазм	Сальбутамол 2,5 мг через небулайзер	
10	Остановка сердца	Базовая СЛР	

Препараты

Препарат	Доза	Путь	Когда
Эпинефрин 0,1%	0,3–0,5 мг (max 0,5 мг)	в/м бедро	Первая линия, немедленно
Эпинефрин (инфузия)	1 мл на 100 мл NaCl	в/в через дозатор	При неэффективности 2 доз в/м
NaCl 0,9%	500–1000 мл	в/в струйно	Сразу
Преднизолон	60–120 мг	в/в, в/м	Вторая линия
Клемастин / Хлоропирамин	2 мг / 20–40 мг	в/в, в/м	Вторая линия
Сальбутамол	2,5 мг	небулайзерная форма 2,5 мг или аэрозоль для ингаляций 4–8 вдохов через спейсер	При бронхоспазме

Мониторинг и госпитализация

Параметр	Частота
АД, пульс, ЧДД, SpO ₂	Каждые 2–5 мин
Госпитализация	Все случаи АШ

Частые ошибки

Ошибка	Почему нельзя
Введение антигистаминных/ГКС вместо эпинефрина	Не купируют гемодинамическую недостаточность
Ожидание эффекта адреналина в/м >5 мин	Потеря времени